Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Bagé

Rua Bento Gonçalves, 499, Direita - Bairro: Centro - CEP: 96400900 - Fone: (53) 3036-8494 - Email: frbage1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002221-28.2022.8.21.0004/RS

AUTOR: NARA XAVIER

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

NARA XAVIER ajuizou ação de rito comum com pedido de tutela de urgência contra **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE-SAÚDE**, postulando, inclusive via tutela provisória de urgência, o fornecimento do medicamento *Pembrolizumab* (K*eytruda*), na quantidade indicada, de acordo com as determinações médicas, ou o valor em dinheiro. Pediu, ainda, a concessão de gratuidade judiciária e a tramitação preferencial do feito.

Na inicial, disse que é portadora de adenocarcinoma gástrico (CID-10: C16.8), com metástases peritoneais, necessitando utilizar o medicamento *Pembrolizumab (Keytruda)*, em virtude do avanço da patologia. Aduziu ter realizado quimioterapia de primeira linha com protocolo *Flot* e segunda linha com *Docetazel*, tendo a doença, no entanto, progredido. Mencionou que o fármaco pleiteado é a melhor opção indicada, visto que poderá controlar a doença e preservar a qualidade de vida da requerente, e que a negativa do tratamento poderá causar risco de óbito. Referiu que a concessão do remédio foi indeferida pela autarquia ré, sob o argumento de não possuir previsão nas recomendações técnicas em oncologia do IPE-Saúde, e que o aludido medicamento possui custo elevado, sendo comercializado somente em hospitais e clínicas, e que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o preço do tratamento. Argumentou acerca da necessidade de manutenção de seu direito à saúde e à vida. Juntou documentos (Evento 1).

O Ministério Público declinou de intervir no feito (Evento 4).

Foi deferida a gratuidade judiciária e a tutela provisória de urgência postulada (Evento 6).

Regularmente citado, o demandado apresentou contestação, sustentando, em suma, ser incabível a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial e que o IPE-Saúde possui protocolo oncológico próprio, não podendo ser compelido à cobertura de tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Aduziu que o medicamento não está previsto em sua tabela nem nas Recomendações Técnicas em Oncologia atualmente vigentes, inexistindo norma jurídica ou contrato que autorize a realização ou o reembolso do tratamento pleiteado. Argumentou que, em caso de eventual condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. Pugnou pela improcedência dos pedidos (Evento 16).

Houve réplica (Evento 19).

Instadas a se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas, as partes nada requereram (Eventos 25 e 27).

O Juízo determinou a intimação da autora para acostar aos autos laudo médico fundamentado de seu médico assistente, indicando a (im)possibilidade de adequação do tratamento em conformidade com a cobertura do plano (Evento 29).

A autora peticionou nos autos, juntando o referido laudo médico, do qual restou intimado o ente público requerido (Eventos 32 e 35).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

Trata-se de analisar pedido de condenação do demandado – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Rio Grande do Sul – IPE-Saúde – ao fornecimento do medicamento *Pembrolizumab* (*Keytruda*), sob o argumento de que a demandante é portadora de adenocarcinoma gástrico (CID-10: C16.8), com metástases peritoneais.

In casu, a relação jurídica existente entre as partes decorre do fato de a autora ser segurada do plano de saúde gerido pelo requerido (Evento 1, OUT6).

Outrossim, os elementos probatórios coligidos ao caderno processual demonstram que a autora é portadora de adenocarcinoma gástrico (CID-10: C16.8), com metástases peritoneais, bem como que já realizou quimioterapia de primeira linha com protocolo *Flot* e segunda linha com *Docetazel*, conforme laudos médicos acostados aos autos, necessitando utilizar, por tempo indeterminado, o medicamento *Pembrolizumab (Keytruda)*, por ser a melhor opção indicada para seu quadro clínico, visto que poderá controlar a doença e preservar sua qualidade de vida.

Entretanto, pelo que se infere dos autos, especialmente do documento anexado no Evento 1, INDEFERIMENTO9, o requerido não autorizou a realização da terapia oncológica com o fármaco acima mencionado, ao argumento de que o medicamento não está previsto em suas recomendações técnicas oncológicas.

Todavia, na situação em apreço, em que pese a negativa de cobertura, mostra-se devido o fornecimento pelo requerido do tratamento médico pleiteado, ainda que a medicação pretendida não esteja elencada no rol das recomendações indicadas pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Rio Grande do Sul – IPE-Saúde.

Com efeito, o artigo 4° da Lei Complementar Estadual n.° 15.145/2018 dispõe que: "*O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*"

Outrossim, conforme se depreende dos artigos 8° e 9° da Resolução n.° 21, de 12 de março de 1979, a especialidade oncologia integra o plano de assistência médica do requerido, abrangendo os serviços de emergência, consultas médicas, serviços complementares, tratamento ambulatorial e tratamento hospitalar.

Além disso, constam nos artigos 41 e 42 da referida Resolução, que regulamenta a assistência médico-hospitalar do requerido, as especialidades e os procedimentos que não são custeados pelo IPE-Saúde, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, muito embora o previsto no artigo 4º, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 15.145/2018, na situação em apreço, o requerido deve assegurar não apenas a assistência médica constante de suas recomendações, mas também todos os meios e recursos necessários para garantir a saúde e vida de seus segurados, incluindo, também, os medicamentos.

Com efeito, o que está em jogo na situação em apreço é o direito à saúde, dignidade e, em última análise, do próprio direito à vida do autor.

Portanto, não se pode deixar a requerente ao desamparo, havendo legislação que prevê de forma expressa a obrigação do requerido em fornecer assistência médica necessária à prevenção da doença. A saúde é direito inafastável, que deve ser assegurado, sob pena de dano absolutamente irreversível para a própria dignidade do demandante. Sem o fornecimento do tratamento indicado, por certo, o problema, que já era grave, iria se agravar mais ainda, causando dor e sofrimento ao requerente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do recente julgamento dos EREsp n.ºs 1.886.929/SP e 1.887.704/SP, entendeu ser taxativo o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), de modo que as operadoras de saúde não estão obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista, assinalando, porém, a possibilidade de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, de forma excepcional, caso não haja substituto terapêutico ou tenham sido esgotados os procedimentos do rol da ANS.

No caso específico dos autos, os documentos médicos coligidos ao caderno processual, em especial os constantes dos Eventos 1 e 32, demonstram que a autora necessita realizar tratamento com o medicamento *Pembrolizumab* (*Keytruda*), em razão de ser portadora de adenocarcinoma gástrico (CID-10: C16.8), cujo fornecimento restou indeferido na via administrativa devido à ausência de previsão do fármaco nas recomendações técnicas em oncologia da autarquia (Evento 1, INDEFERIMENTO9), resultando na propositura da presente ação judicial.

E, nesse aspecto, o profissional médico que acompanha a autora é quem tem melhores condições de receitar a medicação mais adequada ao seu quadro clínico, não podendo a discricionariedade da administração impedir o acesso do segurado ao tratamento médico que lhe é essencial à preservação de saúde e de sua própria vida.

Aliás, o referido profissional, nos laudos médicos aportados aos autos, consignou expressamente que a autora já esgotou as alternativas com quimioterapia de primeira e segunda linha, sendo a medicação prescrita recomendada pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica como alternativa terapêutica em terceira linha de tratamento, bem como que sua utilização apresentou benefício clínico evidente.

Note-se, ainda, que a referida medicação possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANIVSA, conforme indicado na exordial e verificado por este Juízo no sítio do Ministério da Saúde[1], com indicação para o tratamento de pacientes que fizeram cirurgia para remover o melanoma ou carcinoma de células renais para ajudar a prevenir que o câncer retorne ou para tratar o câncer de mama triplo negativo de pacientes antes da cirurgia, que, em seguida, continuam o tratamento para ajudar a prevenir o retorno do câncer.

Ademais, em consulta ao sistema e-NatJus, verifiquei a existência de nota técnica (n.º 66228 – data de conclusão: 02.03.2022) com parecer favorável à utilização do fármaco para tratamento de patologia similar à que acomete a autora. Veja-se trecho da nota contendo as evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia:

> ***"Estudos científicos mostram que a monoterapia com pembrolizumabe é uma opção para tratamento de adenocarcinoma em progressão para pacientes que têm tumores avançados com dMMR, altos níveis de MSI (MSI-H), altos níveis de TMB ou superexpressão de PD-L1 e que não receberam imunoterapia direcionada a PD-1 para primeira linha tratamento. Nos Estados Unidos, pembrolizumab é aprovado para tratamento de terceira linha em pacientes com tumores que expressam PD-L1 (CPS 1 ou superior) após falha de dois regimes de quimioterapia separados, embora o suporte para a escolha de pembrolizumab em vez de quimioterapia de segunda linha para câncer de células escamosas esofágicas (SCC) e adenocarcinomas do esôfago ou junção esofagogástrica (EGJ), Siewert tipo I, que têm um nível mais alto de expressão de PD-L1 (CPS ≥10) é fornecido pelo estudo KEYNOTE-181, o que sugere uma vantagem de sobrevida e melhor tolerabilidade para pembrolizumab nesse cenário. Estudos mostraram o uso de pembrolizumab de segunda linha off label para um paciente com tumor dMMR do estômago ou EGJ, dada a análise de subgrupo do estudo KEYNOTE-061, que mostrou um benefício significativo de sobrevivência para pembrolizumab em relação a um taxano nesse cenário. Outro grupo que pode ser considerado para pembrolizumabe de segunda linha é o subconjunto de pacientes com tumores TMB-H. Em junho de 2020, o pembrolizumabe foi aprovado em vários tipos de tumor***

para o tratamento de pacientes adultos e pediátricos com tumores sólidos TMB-H irressecáveis ou metastáticos, conforme determinado pelo ensaio FoundationOne Cdx, que progrediram após o tratamento anterior e que não apresentaram resultados satisfatórios, como alternativas de tratamento.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia:

- ***aumento da sobrevida global e sobrevida livre de progressão de doença."***

Logo, na esteira da decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência (Evento 6), há que se concluir que o tratamento médico declinado na exordial deve ser fornecido pelo demandado, mesmo que o fármaco não integre os protocolos ou listas adotadas, porquanto se trata de medicamento indispensável para a manutenção da saúde da requerente, bem como que foram esgotadas as demais alternativas terapêuticas disponíveis.

Sobre casos assemelhados, merecem destaque os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPÊ-SAÚDE. ADENOCARCINOMA GÁSTRICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE 200MG. A demanda trata de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. A negativa do IPÊ-SAÚDE se deu sob o fundamento de que o fármaco não está previsto nas atuais recomendações técnicas em oncologia da autarquia A Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o plano de saúde do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, prevê a cobertura de atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento devidos aos usuários. Em que pese a alegação de ausência de previsão no protocolo oncológico, não deve servir de obstáculo ao fornecimento do medicamento pleiteado, levando-se em consideração a previsão da patologia no protocolo, bem como a imprescindibilidade e urgência do tratamento. Ora, o servidor público contribui, durante longo tempo, para ter acesso aos tratamentos médicos de que necessita, não podendo o instituto, em afronta à lei, negar-lhe a assistência médica. Agravo provido. (Agravo de Instrumento, Nº 50882911220228217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 13-07-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CARFILZOMIBE (KYPROLIS®). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS EM ONCOLOGIA. RECUSA ILEGAL. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO QUE NÃO INCIDE NA HIPÓTESE DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO. ARTIGO 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 15.145/2018. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP). 2. No caso dos autos, opõe-se a ré ao fornecimento do medicamento postulado pela parte autora sob o fundamento de que não há previsão de cobertura em suas atuais Recomendações Técnicas em Oncologia. Ocorre que, da análise dos autos, não se vislumbra a existência de alternativa terapêutica eficaz à condição que acomete o demandante. 3. Desta feita, devidamente comprovada a necessidade do medicamento CARFILZOMIBE (KYPROLIS®) para o tratamento da moléstia que acomete a parte autora, impõe-se a condenação do IPE-SAÚDE ao seu fornecimento, ainda que ausente previsão expressa nas tabelas da autarquia previdenciária, em atenção ao entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 4. Coparticipação do usuário que não se aplica ao caso concreto, uma vez que o artigo 30 da LC nº 15.145/2018 não prevê tal medida para o fornecimento de medicamentos. 5. Sentença integralmente mantida. Honorários recursais fixados à luz do §11 do artigo 85 do CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 50070038520218210013, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 27-05-2022).

Outrossim, não há que se falar em ofensa à independência do Poder Executivo, uma vez que a presente decisão é consequência da própria legislação que regulamenta a Assistência Médica Hospitalar do IPE-Saúde, determinando, apenas, que o executivo estadual cumpra com obrigação legal e garanta o direito constitucionalmente assegurado à requerente.

Ainda, ressalto que, em se tratando de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, o segurado não está sujeito à coparticipação, tendo em vista o disposto no artigo 30, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n.º 15.145/2018.

A única ressalva a ser feita é quanto ao fornecimento da medicação pleiteada de acordo com a Denominação Comum Brasileira (DCB), conforme determina a Lei n.º 9.787/1999.

Por fim, no que diz com as custas processuais, tendo em vista que o feito foi ajuizado posteriormente à vigência da Lei Estadual n.° 14.634/2014, ou seja, após 15.06.2015, o requerido resta isento do pagamento, em virtude do disposto no artigo 5°, inciso I, do aludido diploma legal

De tudo o que foi exposto, tenho que deve ser acolhido o pedido declinado na inicial.

ISTO POSTO, julgo **procedente** o pedido aforado por **NARA XAVIER** contra **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE-SAÚDE,** para o fim de condenar o requerido a fornecer à autora o tratamento oncológico com o medicamento *Pembrolizumab* (K*eytruda*)*,* de acordo com as determinações médicas, nas quantidades prescritas, observada a Denominação Comum Brasileira (DCB), nos termos da fundamentação, confirmando a tutela provisória de urgência concedida no Evento 6.

Condeno o demandado, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios da procuradora da parte requerente, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração o trabalho realizado pela profissional e a natureza do feito, a teor do artigo 85 e §§ do CPC. Sem condenação em custas, porquanto o requerido goza de isenção legal, nos termos da fundamentação.

Com o trânsito em julgado, proceda-se a baixa do feito.

Publicação, registro e intimação efetivados de forma eletrônica.

---

1 *Vide*: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351150453202160/?nomeProduto=keytruda

---

Documento assinado eletronicamente por **HUMBERTO MOGLIA DUTRA, Juiz de Direito**, em 16/9/2022, às 18:7:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10025573119v3** e o código CRC **6120eb6c**.